MEDIFLOW · HACKATHON ONE G10

Oracle Next Education & Alura · Grupo 10

Mapa de documentos de teste

Quantos fixtures o MediFlow precisa, quais são e o que cada um prova

PROJETO	MediFlow — triagem, extração e roteamento de documentos clínicos
VERSÃO	1.0 — 19/10/2026
BASE DOCUMENTAL	Projeto_oracle.pdf · Análise de Requisitos v1.1 · Especificação Funcional v1.0
ESCOPO	MVP do hackathon — somente dados fictícios, OCI Always Free

67	67	252	8
fixtures no catálogo	já produzidos	arquivos no repositório	simulações sem arquivo

Como este mapa está organizado

— Seção 1 — cobertura: os 8 tipos controlados contra os 4 formatos de entrada.

— Seção 2 — fluxo de decisão que cada fixture exercita (rotina, urgência, ambiguidade, erro).

— Seção 3 — kit de demonstração: os 12 casos de pitch, com TXT, PDF, JPG e expected.json.

— Seção 4 — catálogo completo dos 67 fixtures, bloco por bloco, com destino e status esperados.

— Seção 5 — pendências da especificação e como regenerar o catálogo.

AVISO

Todos os documentos deste catálogo são fictícios: nomes, CRMs, CID e resultados existem apenas para testar o agente. Nenhum dado de paciente real é usado.

1. Cobertura: tipos × formatos

A matriz 8 × 4 é o piso do catálogo. Os números indicam quantos fixtures existem em cada célula.

TIPO DE DOCUMENTO	PDF	PDF escaneado	Imagem	Texto	Total
RECEITUARIO_MEDICO	2	1	4	6	13
LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	5	1	1	2	9
LAUDO_EXAME_IMAGEM	4	1	3	1	9
GUIA_PROCEDIMENTO	2	1	2	3	8
RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	3	1	1	1	6
ATESTADO_MEDICO	1	1	2	2	6
OUTRO	1	1	1	1	4
NAO_IDENTIFICADO	1	—	2	1	4

Leituras que mudam o plano

- OUTRO e NAO_IDENTIFICADO não são tipos que se escrevem: são resultados de classificação. Por isso cada um entra com 3 testes negativos (documento fora da taxonomia ou ilegível).
- JSON não é tipo de documento: é apenas o envelope da API. Um texto enviado como JSON continua sendo um documento de texto.
- PDF digital e PDF escaneado têm caminhos de leitura diferentes (RF-02/RF-04) e por isso colunas separadas.
- Especialidade médica é texto livre (RF-06) — não existe lista fechada e não é preciso um documento por especialidade.

Composição do catálogo por bloco

Bloco	O que cobre	Arquivos	Acumulado
M	Matriz tipos × formatos	24	24
A	Ausência de campos	8	32
B	Fronteira do limiar (0,84 e 0,85)	2	34
C	Conflitos, contradições e alto risco	5	39
S	Urgência + ambiguidade simultâneas	2	41
Q	Qualidade, ilegibilidade e PDFs especiais	8	49
V	Negativos técnicos de entrada	8	57
E	PDF escaneado dos 6 tipos restantes	6	63
D	Diferenciais opcionais	4	67

MÍNIMO LITERAL DOS CRITÉRIOS DE ACEITE (§16)

8 arquivos: texto + um PDF + uma imagem do mesmo caso, mais as 5 variações de campo ausente.
Passa na leitura literal, mas não prova os 5 destinos nem as 8 classes de tipo. Não use como meta.
Meta recomendada: 57 arquivos. Demonstração mínima: 12.

2. Fluxo de decisão que os fixtures exercitam

Cada caminho precisa de pelo menos um documento diferente para ser comprovado.

RF-01 / RF-02
1. ENTRADA
PDF digital · PDF escaneado
Imagem · texto

→

RF-03
2. VALIDAÇÃO
formato, tamanho, MIME
envelope da requisição

→

RF-04
3. LEITURA
Gemini multimodal
classificação + extração

→

RF-16 a RF-19
4. GRAFO
scores, conflitos
regras determinísticas

Cinco desfechos possíveis

URGENTE / CRÍTICO
destino FILA_URGENCIA_MEDICA
alerta simulado registrado
status EM_REVISAO

AMBÍGUO / ILEGÍVEL
destino FILA_REVISAO_HUMANA
campos incertos preservados
status EM_REVISAO

ROTINA (score ≥ 0,85)
FARMACIA · AUDITORIA · PRONTUARIO
revisão apenas se outra regra exigir
status PROCESSADO

Fixture que exercita cada caminho

Caminho	Fixtures	Bloco
Rotina	M-REC-TXT · M-REC-PDF · M-LAB-PDF · M-GUI-PDF · M-ALT-PDF · M-ATE-TXT	M
Urgência	M-REC-IMG · M-IMG-PDF · C-ALTO-RISCO	M · C
Ambiguidade	M-NID-IMG · M-OUT-TXT · A-PAC-NOME · B-084	M · A · B
Urgência + ambiguidade	S-URG-ILEGIVEL · S-URG-SCORE	S
Erro de entrada	V-DOCX · V-VAZIO · V-JSON-MALFORMADO · V-MIME	V
Erro de provedor/OCI	F-GEMINI-TIMEOUT · F-OCI-ORIGINAL (sem arquivo novo)	F

Regras de bolso

— Urgência nunca vira rotina, mesmo com score baixo (RN-03, RNF-02).
— Score combinado = mínimo entre classificação e extração; abaixo de 0,85 obriga revisão (RF-18).
— Cinco ausências obrigam revisão: nome do paciente, idade, nome do médico, CRM e diagnóstico.
— CID, medicamentos e exames ausentes NÃO obrigam revisão por si só (RF-21).
— Nada é preenchido por inferência: ausente fica null e entra em campos_ausentes (RF-15).

3. Kit de demonstração — 12 casos prontos

Cada caso foi gerado em TXT, PDF e JPG, com expected.json ao lado. Caminho: tests/fixtures/demo/

#	ID	Caso	Destino esperado	Status	Rev.
1	M-REC-TXT	Receituário — rotina (texto)	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—
2	M-REC-PDF	Receituário — rotina, 2 medicamentos (PDF)	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—
3	M-REC-IMG	Receituário — urgência com opioide (imagem)	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	SIM
4	M-IMG-PDF	TC de tórax — TEP agudo (PDF)	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	SIM
5	M-LAB-PDF	Hemograma — rotina (PDF)	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—
6	M-GUI-PDF	Guia de ressonância — eletiva (PDF)	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—
7	M-ALT-PDF	Relatório de alta — pneumonia (PDF)	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—
8	M-ATE-TXT	Atestado de comparecimento (texto)	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—
9	M-NID-IMG	Documento ilegível (imagem degradada)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM
10	M-OUT-TXT	Comunicação administrativa (texto)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM
11	A-PAC-NOME	Receita sem nome do paciente (texto)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM
12	B-084	Receita com score forçado 0,84 (texto)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM

Conteúdo de cada pasta

Arquivo	O que é	Formato
{ID}.txt	Documento em texto puro	UTF-8
{ID}.pdf	Mesma peça em PDF digital, com camada de texto	PDF 1.4
{ID}.jpg	Mesma peça fotografada e levemente inclinada	JPEG 150 dpi
expected.json	Saída esperada: tipo, prioridade, destinos, revisão, asserções	JSON

Cobertura do kit

— 5 destinos lógicos: urgência, farmácia, auditoria de autorizações, prontuário e revisão humana.

— 3 formatos de entrada + 8 classes de tipo (6 clínicos, OUTRO e NAO_IDENTIFICADO).

— 3 cenários obrigatórios do hackathon: rotina, urgência e ambiguidade.

— 2 regras de borda: ausência de campo obrigatório e score abaixo de 0,85.

4. Catálogo completo — 67 fixtures

Rev = requer auditoria humana · OK = fixture produzido e versionado

4.1 Bloco M — Matriz tipos × formatos (24)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
M-REC-PDF	RECEITUARIO_MEDICO	Pdf	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓
M-REC-IMG	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓
M-REC-TXT	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓
M-LAB-PDF	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-LAB-IMG	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-LAB-TXT	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-IMG-PDF	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓
M-IMG-IMG	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓
M-IMG-TXT	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-GUI-PDF	GUIA_PROCEDIMENTO	Pdf	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	✓
M-GUI-IMG	GUIA_PROCEDIMENTO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓
M-GUI-TXT	GUIA_PROCEDIMENTO	Texto	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	✓
M-ALT-PDF	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-ALT-IMG	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-ALT-TXT	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-ATE-PDF	ATESTADO_MEDICO	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-ATE-IMG	ATESTADO_MEDICO	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-ATE-TXT	ATESTADO_MEDICO	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-OUT-PDF	OUTRO	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-OUT-IMG	OUTRO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-OUT-TXT	OUTRO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-NID-PDF	NAO_IDENTIFICADO	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-NID-IMG	NAO_IDENTIFICADO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-NID-TXT	NAO_IDENTIFICADO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓

4.2 Bloco A — Ausência de campos (8)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
A-PAC-NOME	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
A-PAC-IDADE	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
A-MED-NOME	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
A-MED-CRM	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
A-DIAG	GUIA_PROCEDIMENTO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
A-CID-SO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
A-MEDIC-SO	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
A-EXAMES-SO	ATESTADO_MEDICO	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓

4.3 Bloco B — Fronteira do limiar (2)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
B-084	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
B-085	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓

4.4 Bloco C — Conflitos e alto risco (5)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
C-CID-CONFLITO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
C-DOSE	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
C-PRIORIDADE	GUIA_PROCEDIMENTO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
C-DADOS	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
C-ALTO-RISCO	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓

4.5 Bloco S — Urgência + ambiguidade (2)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
S-URG-ILEGIVEL	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
S-URG-SCORE	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓

4. Catálogo completo (continuação)

Rev = requer auditoria humana · OK = fixture produzido e versionado

4.6 Bloco Q — Qualidade, ilegibilidade e PDFs especiais (8)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
Q-FOTO-DESFOCO	NAO_IDENTIFICADO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
Q-FOTO-ROTACAO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
Q-FOTO-CORTADA	GUIA_PROCEDIMENTO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
Q-FOTO-BAIXA	ATESTADO_MEDICO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
Q-PDF-SEM-TEXTO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
Q-PDF-MULTIPAGINA	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
Q-PDF-SENHA	RECEITUARIO_MEDICO	Pdf	Erro	N/A	ERRO_PROCESSAMENTO	—	✓
Q-PDF-CORROMPIDO	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Erro	N/A	ERRO_PROCESSAMENTO	—	✓

4.7 Bloco V — Negativos técnicos de entrada (8)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
V-DOCX	N/A	Docx	Erro	N/A	415 FORMATO_NAO_SUPORTA...	—	✓
V-VAZIO	N/A	Arquivo 0Kb	Erro	N/A	422 CAMPOS_INVALIDOS	—	✓
V-JSON-MALFORMADO	N/A	Json	Erro	N/A	400 REQUISICAO_INVALIDA	—	✓
V-ENVELOPE	N/A	Json	Erro	N/A	422 CAMPOS_INVALIDOS	—	✓
V-SEM-CONTEUDO	N/A	Multipart	Erro	N/A	422 CAMPOS_INVALIDOS	—	✓
V-ZIP	N/A	Zip	Erro	N/A	415 FORMATO_NAO_SUPORTA...	—	✓
V-GRANDE	N/A	Arquivo 25Mb	Erro	N/A	413 ARQUIVO_MAIOR_QUE_LIM...	—	✓
V-MIME	N/A	Pdf Falso	Erro	N/A	415/422 MIME_INVALIDO	—	✓

4.8 Bloco E — PDF escaneado dos tipos restantes (6)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
E-REC-PDFSCAN	RECEITUARIO_MEDICO	Pdf Digitalizado	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓
E-LAB-PDFSCAN	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
E-GUI-PDFSCAN	GUIA_PROCEDIMENTO	Pdf Digitalizado	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	✓
E-ALT-PDFSCAN	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
E-ATE-PDFSCAN	ATESTADO_MEDICO	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
E-OUT-PDFSCAN	OUTRO	Pdf Digitalizado	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓

4.9 Bloco D — Diferenciais opcionais (4)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
D-MANUSCRITA	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓
D-CARIMBO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
D-HEMOGRAMA	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
D-GUIA-TISS	GUIA_PROCEDIMENTO	Pdf	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	✓

Cada linha corresponde a um arquivo de entrada. Os blocos V e F usam envelope de erro, não JSON de triagem.

5. Pendências e regeneração

Pontos abertos na especificação v1.0 (§15) que ainda impedem resposta inequívoca em parte dos fixtures.

Pendência	O que fica bloqueado	Recomendação
Limite de tamanho, páginas, MIME, timeout e retry	V-GRANDE, Q-PDF-MULTIPAGINA, F-*	Fixar: 10 MB, 10 páginas, timeout 30 s, 2 retries
Contrato final do upload (multipart × JSON)	V-SEM-CONTEUDO, V-ENVELOPE, V-MIME	Multipart para arquivo; JSON para texto
Dicionário de achado crítico e alto risco	C-CID-CONFLITO, C-DOSE, C-ALTO-RISCO	Criar rules/cid10.csv e rules/medicamentos_alto_risco.csv
Urgência isolada exige revisão?	Todos os casos URGENTE	Spec diz sim (§8.2/§5.3); o exemplo do brief diz não. Padronizar.
Autenticação e autorização	403 e consulta por terceiros	Fora do MVP; se entrar, criar fixture de acesso negado
Política de retenção e exclusão	Teste de persistência no OCI	Definir antes de qualquer dado real (que não deve existir)
Meta de latência e precisão	F-GEMINI-TIMEOUT, F-RETRY	Medir o primeiro pipeline e só então fixar a meta

Como regenerar o catálogo

1. Instalar as dependências: python3 -m pip install reportlab pymupdf pillow.
2. python3 tools/gerar_fixtures_demo.py — recria os 12 casos do kit de demonstração.
3. python3 tools/gerar_fixtures_catalogo.py — recria os 55 restantes, incluindo PDFs escaneados, senha e corrompido.
4. python3 tools/gerar_mapa_documentos.py — recria este PDF.
5. Rodar o pipeline e comparar por asserção, nunca por score exato do LLM.

REGRA DE OURO DOS FIXTURES

Nunca compare score exato do modelo: ele não é probabilidade calibrada (RF-17).
Compare faixas (< 0,85) e, nas bordas, use FIXTURE_MODE para forçar os scores.

6. Arquivos e referências

Tudo versionado no repositório, exceto os PDFs de origem que ficam no Google Drive.

Arquivo	Conteúdo
docs/testes/CATALOGO_DE_DOCUMENTOS_DE_TESTE.md	Catálogo analítico completo, regras e rastreabilidade
docs/testes/Mapa_de_Documentos_de_Teste_MediFlow.pdf	Este documento
tests/fixtures/manifest.csv	Os 67 fixtures em formato de máquina
tests/fixtures/demo/	12 casos de pitch × (TXT + PDF + JPG + expected.json)
tests/fixtures/catalogo/	55 casos restantes, incluindo os 8 negativos técnicos
tools/gerar_fixtures_*.py	Geradores reprodutíveis de todo o catálogo
tests/fixtures/README.md	Convenção de nomes e regras de produção
README.md	Visão do produto, arquitetura e critérios de aceite

Base documental (Google Drive)

— Projeto_oracle.pdf — brief do hackathon: formatos, entregáveis e checklist de avaliação.

— MediFlow_-_Análise_de_Requisitos_v1.1.pdf — requisitos RF/RNF/RN e decisões do time.

— MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf — §5 vocabulário, §7 requisitos, §8 regras, §16 critérios de aceite.

Este documento e todos os fixtures citados usam exclusivamente dados fictícios, em conformidade com a decisão registrada na seção 15 da especificação funcional. Nenhum nome, CRM, CID ou resultado clínico corresponde a pessoa real.